

A modern dental clinic with a microscope, dental chair, and various medical equipment. The scene is brightly lit with warm, golden light, creating a professional and clean atmosphere. In the foreground, a microscope is prominently displayed on the left, and a dental chair is visible in the background. A tray of dental tools and a small container are on the table in the foreground. The text is overlaid on the right side of the image.

O USO RACIONAL DOS
ANTIBIÓTICOS
NA ODONTOLOGIA



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA • ODONTOLOGIA

O Uso Racional dos Antibióticos na Odontologia

Prescrição consciente, resistência bacteriana e segurança do paciente

Roteiro da Apresentação

01

Introdução & Contexto

Problema, objetivos e metodologia da pesquisa

02

História dos Antibióticos

Da descoberta da penicilina ao uso odontológico

03

Uso Racional na Prática

Indicações terapêuticas e profiláticas

04

Endocardite & Grupos de Risco

Pacientes que exigem profilaxia antibiótica

05

Protocolos & Extrações

Amoxicilina, alternativas e terceiros molares

06

Resistência & Controle

Consequências globais e medidas regulatórias

PARTE 1

Introdução & Contexto

O panorama do uso de antibióticos na prática odontológica contemporânea



O Que São os Antibióticos?



Substâncias com a capacidade de interagir com microrganismos causadores de infecções, matando-os (bactericidas) ou inibindo sua reprodução (bacteriostáticos), permitindo que o sistema imunológico os combata com maior eficácia.

1

Ação bactericida

Promovem a morte direta da célula bacteriana.

2

Ação bacteriostática

Inibem o crescimento e a multiplicação microbiana.

3

Papel na odontologia

Uso terapêutico (infecção instalada) e profilático (prevenção).

“

Como a administração não criteriosa dos antibióticos na prática odontológica pode contribuir para a resistência bacteriana?

Problema de pesquisa central do artigo (Souza, Costa Junior & Pinto, 2024)

ANTIMICROBIAL RESISTANCE DASHBOARD

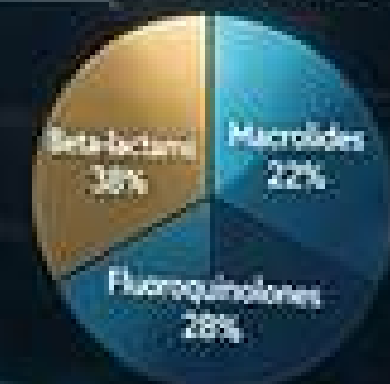
RESISTANCE TREND 2020-2024



BACTERIAL RESISTANCE PROFILE

E. coli	32%
MRSA	18%
K. pneumoniae	41%
P. aeruginosa	25%

RESISTANCE BY ANTIBIOTIC CLASS



AMR RISK INDEX: MODERATE-HIGH • +2.1% YoY

RECOMMENDATION: STEWARDSHIP PROTOCOL
UPDATED • REVIEW ALTERNATIVE ANTIBIOTICS

DR. L. CHAMBERS
CHIEF DENTAL OFFICER

Objetivo Geral e Específicos

Objetivo Geral

- Apresentar a importância do uso racional dos antibióticos na odontologia.
- Analisar a resistência bacteriana como consequência do emprego indiscriminado desses fármacos.

Objetivos Específicos

- Abordar o contexto histórico dos antibióticos.
- Descrever como deve ser o uso racional dos antibióticos.
- Verificar as medidas de controle adotadas pelos órgãos vigentes.

Desenho do Estudo



Revisão Bibliográfica

Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, sem uso de métodos estatísticos.



Bases de Dados

Google Acadêmico, SciELO, PubMed, teses, monografias, livros e sites oficiais.



Descritores

“antibiotics in dentistry”, “bacterial resistance” e “prescrição antibiótica”.



Amostra Final

22 materiais selecionados: 14 artigos, 2 livros, 1 tese, 2 monografias e 3 sites.



Período Coberto

Publicações de 2001 a 2023, em idiomas nacional e internacional.



Abrangência

Contexto mundial, cobrindo consequências do uso irracional para a população.

Marcos Históricos dos Antibióticos



PARTE 2

Contexto Histórico

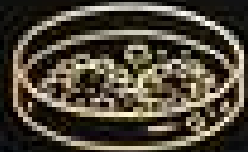
Da descoberta acidental da penicilina à consolidação do uso odontológico



LINHA DO TEMPO CIENTÍFICA

Da Descoberta da Penicilina à Gestão Moderna dos Antimicrobianos

Da descoberta ao uso responsável: quase um século de progresso contra a resistência antimicrobiana



1928 • DESCOBERTA DA PENICILINA

Alexander Fleming observa o efeito antibacteriano do fungo *Penicillium notatum*, identificando a penicilina como o primeiro antibiótico natural.

- Início da era antibiótica moderna



ANOS 1960-1980 A ERA DE OURO DOS ANTIBIÓTICOS

Desenvolvimento de novas classes de antibióticos: tetraciclínas, cefalosporinas, macrolídeos.

- Explosão de inovação farmacológica e terapias antimicrobianas



2015 • LANÇAMENTO DO GLASS

Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System.

- WHA68.7: sistema global de coleta padronizada de dados sobre RAM



GESTÃO ANTIMICROBIANA NA ODONTOLOGIA

Protocolos de stewardship antimicrobiano na prática odontológica.

- Diretrizes para prescrição responsável, prevenção de infecções e redução do uso desnecessário



DÉCADA DE 1940 • PRODUÇÃO EM MASSA DA PENICILINA

Avanços na fermentação e produção industrial permitem o uso clínico em larga escala durante a Segunda Guerra Mundial.

- Penicilina salva milhões de vidas, transformando a medicina



2015 • PLANO DE AÇÃO GLOBAL DA OMS SOBRE RAM

Adotado pela Assembleia Mundial da Saúde – WHA67.25.

- Estratégia global para combater a resistência antimicrobiana com enfoque em vigilância, prevenção e uso responsável



2024-2025 • 141 PAÍSES PARTICIPAM DO GLASS

Rede global de vigilância ativa em expansão.

- Mais de 140 países fornecem dados nacionais para monitoramento da resistência antimicrobiana desnecessária

GESTÃO ANTIMICROBIANA • PREVENIR A RESISTÊNCIA • PROTEGER O FUTURO • USO RESPONSÁVEL • SAÚDE ÚNICA (ONE HEALTH)

1928 Alexander Fleming descobre a penicilina, de forma accidental.



Os Primeiros Usos em Cirurgia Oral



1

Lewis & Grant (1923)

Propuseram que bacteremias odontológicas poderiam causar infecções a distância.

2

Budnitz et al. (1942)

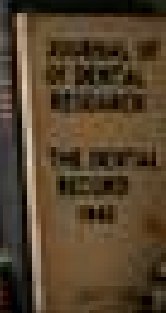
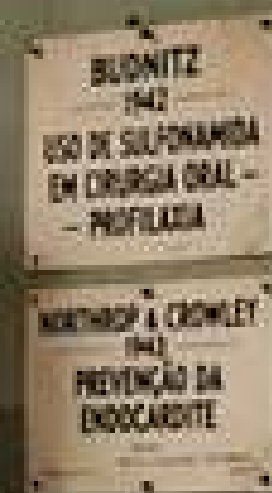
Introduziram antimicrobianos à base de sulfas antes de cirurgias orais.

3

Northrop & Crowley (1943)

Reforçaram o uso preventivo em pacientes susceptíveis à endocardite.

Na década de 40, os antibióticos passaram a ser usados no controle de infecções pós-operatórias em cirurgias orais, motivados pela preocupação com infecções à distância — como a endocardite bacteriana.



Evolução das Diretrizes da American Heart Association

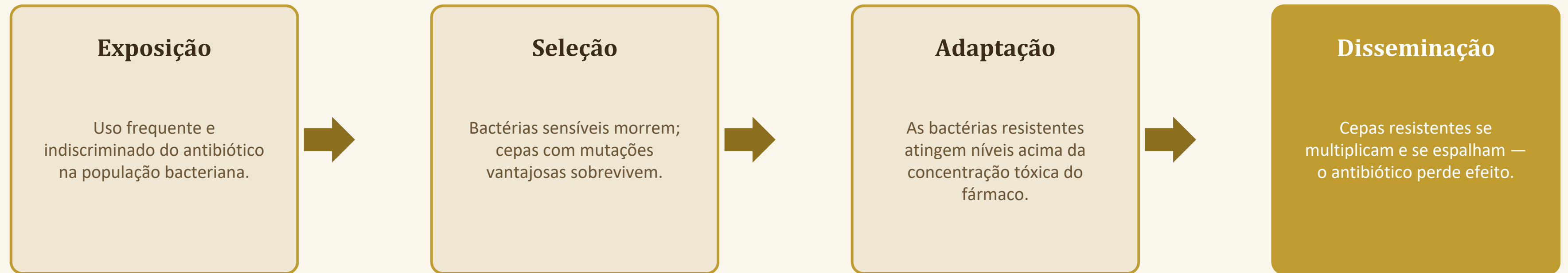


“

O que sobrevive não é o mais forte, e sim aquele que se adapta melhor.

Charles Darwin — citado a propósito da seleção de cepas resistentes (Silveira et al., 2006)

Como Surge a Resistência Bacteriana



RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA:

UMA CRISE GLOBAL E O PAPEL DA ODONTOLOGIA

MICROORGANISMOS MAIS FORTES • ANTIBIÓTICOS MAIS FRACOS • UM DESAFIO PARA TODOS



MORTES ASSOCIADAS

4,71 MILHÕES

Mortes associadas à resistência antimicrobiana em 2021.



MORTES ATRIBUÍVEIS

1,14 MILHÃO

Mortes diretamente atribuíveis à resistência bacteriana em 2021.



INFECÇÕES RESISTENTES

1 EM CADA 6

Infecções bacterianas confirmadas laboratorialmente apresentaram resistência aos antibióticos em 2023.



AMEAÇA GLOBAL

TOP 10

A resistência antimicrobiana permanece entre as maiores ameaças globais à saúde pública.



O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA



Prescrever apenas quando houver indicação clínica



Evitar uso profilático inadequado



Seguir protocolos baseados em evidências



Promover *stewardship* antimicrobiano

SAÚDE BUCAL TAMBÉM É PARTE DESSA SOLUÇÃO

Plano de Ação Global sobre Resistência Antimicrobiana

Capa do plano de ação global

Plano de Ação Global sobre Resistência Antimicrobiana (2015)

A resistência antimicrobiana (RAM) é um grave problema de saúde pública mundial. Ela ameaça o próprio cerne da medicina moderna e a sustentabilidade de uma resposta global e eficaz de saúde pública à ameaça persistente de doenças infecciosas. O uso indevido e excessivo desses medicamentos na medicina humana e na produção de alimentos colocou todas as nações em risco. Há poucos produtos substitutos em desenvolvimento. Sem uma ação harmonizada e imediata em escala global, o mundo caminha para uma era pós-antibiótica na qual infecções comuns poderão, mais uma vez, matar.

O "Plano de Ação Global" para enfrentar o crescente problema da resistência a antibióticos e outros medicamentos antimicrobianos foi aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2015, na resolução WHA67.25. O objetivo do plano é garantir a continuidade do tratamento e da prevenção eficazes de doenças infecciosas com medicamentos eficazes e seguros, com qualidade assegurada, utilizados de forma responsável e acessíveis a todos que deles necessitem.

Os 5 objetivos delineados no "Plano de Ação Global" são:

Aumentar a conscientização e a compreensão da resistência antimicrobiana.

fortalecer o conhecimento por meio da vigilância e da pesquisa

reduzir a incidência de infecção

otimizar o uso de agentes antimicrobianos

Garantir o investimento sustentável no combate à resistência antimicrobiana.



O "Plano de Ação Global" fornece uma estrutura para o desenvolvimento de planos de ação nacionais, incluindo ações-chave que os diversos atores devem tomar dentro de 5 a 10 anos para combater a resistência antimicrobiana. Sistema Global de Vigilância da Resistência e Uso de Antimicrobianos (GLASS)

A resistência antimicrobiana (RAM) representa uma grande ameaça à saúde humana, com implicações significativas para a economia e a segurança globais. Em 2015, os Estados-Membros da OMS aprovaram por unanimidade um Plano de Ação Global para o Combate à RAM (GAP-RAM). O objetivo do GAP-RAM é “garantir, pelo maior tempo possível, a continuidade do tratamento e da prevenção eficazes de doenças infecciosas com medicamentos eficazes e seguros, de qualidade assegurada, utilizados de forma responsável e acessíveis a todos que deles necessitem”.

A vigilância é uma ferramenta essencial para orientar políticas e respostas de prevenção e controle de infecções. É importante ressaltar que ela é a base para avaliar a disseminação da resistência antimicrobiana (RAM) e para informar e monitorar o impacto de estratégias locais, nacionais e globais. Em 22 de outubro de 2015, a OMS lançou o Sistema Global de Vigilância da Resistência e Uso de Antimicrobianos (GLASS) , o primeiro esforço colaborativo global para padronizar a vigilância da RAM. Aprovado pela 68ª Assembleia Mundial da Saúde na resolução WHA68.7, o GLASS foi criado para apoiar o segundo objetivo da iniciativa GAP-AMR, que é “fortalecer o conhecimento por meio da vigilância e da pesquisa”, e para continuar preenchendo lacunas de conhecimento, com o objetivo de orientar estratégias em todos os níveis.

ESCOPO

O GLASS fornece uma abordagem padronizada para a coleta, análise, interpretação e compartilhamento de dados entre países e busca apoiar ativamente o desenvolvimento de capacidades e monitorar o status dos sistemas nacionais de vigilância existentes e novos. Além disso, o GLASS promove uma mudança de abordagens de vigilância baseadas exclusivamente em dados laboratoriais para um sistema que inclua dados epidemiológicos, clínicos e populacionais . O GLASS foi concebido para incorporar progressivamente dados da vigilância da resistência antimicrobiana (RAM) em humanos, como o monitoramento da resistência e o uso de medicamentos antimicrobianos, incluindo a RAM na cadeia alimentar e no meio ambiente.

ESTRUTURA

Os diversos tipos de atividades de vigilância relacionadas à resistência antimicrobiana (RAM) lideradas pelo GLASS são agrupados em uma série de módulos técnicos . Esses módulos compreendem atividades de vigilância baseadas em dados rotineiramente disponíveis (por exemplo, amostras de pacientes coletadas para fins clínicos ou vendas nacionais de antimicrobianos) e atividades focadas na geração de informações para fins específicos, com base nas necessidades de países e regiões. O GLASS também se dedica ao planejamento e à implementação de pesquisas e estudos que visam auxiliar os países a obterem dados de melhor qualidade e representatividade. Além disso, o GLASS oferece suporte, incluindo diretrizes baseadas em evidências e documentos técnicos, para auxiliar países e regiões a desenvolverem capacidades e a tomarem medidas corretivas apropriadas e oportunas.

PARCERIAS

O projeto GLASS atua nos três níveis da OMS – sede, escritórios regionais e nacionais – e conta com o apoio da Rede de Centros Colaboradores de Vigilância e Avaliação da Qualidade da Resistência Antimicrobiana da OMS (Rede de Centros Colaboradores de Vigilância da Resistência Antimicrobiana da OMS). O projeto goza de forte comprometimento dos países participantes e de estreita colaboração com redes regionais de resistência antimicrobiana, como a Rede de Vigilância da Resistência Antimicrobiana da Ásia Central e Europa (CAESAR), a Rede Europeia de Vigilância da Resistência Antimicrobiana (EARS-Net), a Rede Latino-Americana de Vigilância da Resistência Antimicrobiana (ReLAVRA) e o Sistema Regional de Vigilância do Consumo de Antimicrobianos do Pacífico Ocidental (WPRACSS).



5 OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

5

Plano de Ação Global
AMR • WHA67.25



2015 ANO
WHA67.25

2015

Adoção pela Assembleia
Mundial da Saúde



141 PAÍSES, TERRITÓRIOS
E ÁREAS

141

Comprometidos com o
GLASS • Dez 2024



27/47 ÁFRICA
REPORTANDO

57%

Cobertura de reporte
GLASS-AMR 2024



COBERTURA GLASS • REDES REGIONAIS
CAESAR • EARS-Net • ReLAVRA • WPRACSS



• Rede CAESAR (Europa) • EARS-Net (Europa) • ReLAVRA (Américas)
• WPRACSS (Pacífico Ocidental)



PARTICIPAÇÃO OFICIAL
GLASS • DEZ 2024

141 CTAs comprometidos	141
127 países GLASS-AMR	127
104 países com dados AMR 2023	104
27/47 África • 57%	57%

*Referente ao período 2023 • Fonte: WHO GLASS Dashboard, Dez 2024



TENDÊNCIA • CRESCIMENTO
GLASS 2015-2025



30 141

2015 • 2017 • 2019 • 2021 • 2023 • 2025

• 371% crescimento 2015-2024 • 141 CTAs em Dez 2024



DISTRIBUIÇÃO DOS 5 OBJETIVOS
OMS • PLANO DE AÇÃO GLOBAL AMR



20%
CADA OBJETIVO



1. Melhorar conscientização e compreensão da AMR

2. Fortalecer conhecimento e base de evidências via vigilância

3. Reduzir incidência de infecção via higiene e prevenção

4. Otimizar o uso de antimicrobianos em saúde humana e animal

5. Investimento sustentável e P&D em novos medicamentos



INSIGHTS CHAVE • AMEAÇA OFICIAL DA AMR

- A resistência antimicrobiana é uma das maiores ameaças à saúde global, colocando em risco tratamentos médicos e saúde pública
- Em 2024, 141 países/territórios/áreas comprometidos com o GLASS para fortalecimento da vigilância global
- 27 dos 47 países da Região Africana (57%) reportaram dados AMR ao GLASS em 2023, destacando progresso na cobertura regional
- 104 países compartilharam dados de resistência antimicrobiana em 2023, crescimento contínuo desde 2015

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA - O PANORAMA GLOBAL - WHO GLASS 2025

104 países, 1 crise silenciosa



54,3%

Acinetobacter resistente a carbapenêmicos



44,8%

E. coli resistente a cefalosporinas 3ª geração



52,7%

Uso Access
(meta 70% até 2030)

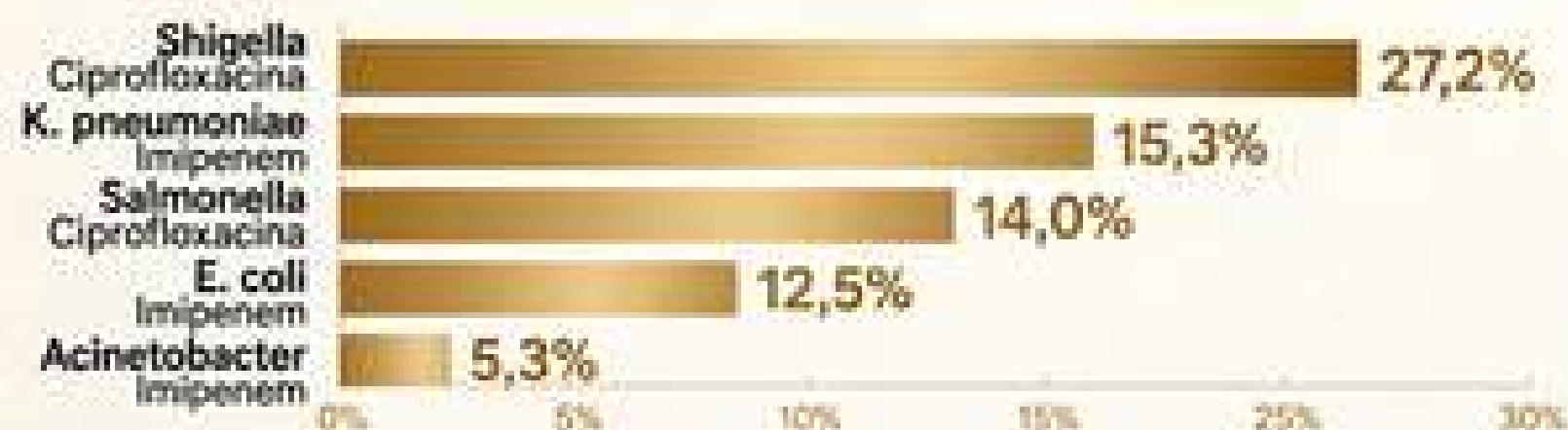


1,3%

Labs África Subsaariana
com bacteriologia

• TENDÊNCIAS ALARMANTES 2018–2023

Resistência por patógeno e antibiótico — aumento percentual 2018–2023



• O PARADOXO DA VIGILÂNCIA

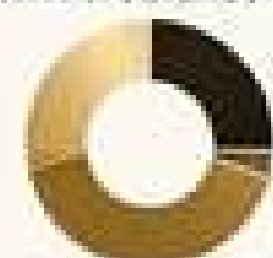
Correlação entre cobertura de vigilância e taxa de resistência reportada - $r = -0,74$



Fortes evidências: países com menor cobertura de vigilância reportam maiores taxas de resistência

A SINDEMIA

Uso AWaRe de Antimicrobianos — Global 2023 - $r = -0,77$



Access
52,7%

Watch
45,3%

Reserve
0,3%

Access 52,7%

Watch 45,3%

Reserve 0,3%

Meta OMS: ≥60% Access até 2030

5 PRIORIDADES PARA AÇÃO

- 1 Fortalecer vigilância laboratorial global (WHO GLASS)
- 2 Implementar programas de stewardship antimicrobiano
- 3 Ampliar acesso a laboratórios de bacteriologia na África Subsaariana
- 4 Regular uso de antimicrobianos no setor animal e agrícola
- 5 Investir em P&D para novos antibióticos e diagnósticos rápidos



Resistência antimicrobiana

16 de julho de 2026 | Tempo de leitura: 5 min (1463 palavras)

Fatos principais

- A resistência antimicrobiana (RAM) ocorre quando bactérias, vírus, fungos e parasitas não respondem aos medicamentos antimicrobianos. Como resultado, as infecções tornam-se difíceis ou impossíveis de tratar, aumentando o risco de disseminação da doença, enfermidades graves, incapacidade e morte.
- A resistência antimicrobiana (RAM) é uma grande ameaça à saúde global. Estima-se que a RAM bacteriana esteja associada a mais de 4,7 milhões de mortes em todo o mundo em 2021 (1).
- O uso indevido e excessivo de antimicrobianos está impulsionando o desenvolvimento e a disseminação de patógenos resistentes a medicamentos.
- A falta de acesso adequado a vacinas, diagnósticos e medicamentos novos e existentes também contribui para a crise.
- Em 2023, aproximadamente 1 em cada 6 infecções bacterianas confirmadas em laboratório em todo o mundo eram resistentes a antibióticos.
- O mundo enfrenta uma crise na pesquisa e desenvolvimento de antimicrobianos, com poucos novos medicamentos em fase de desenvolvimento.



Lar > Pesquisa e análise > Tópicos de saúde ▾

Resistência antimicrobiana (RAM)

A resistência antimicrobiana (RAM) representa uma grande ameaça à saúde humana em todo o mundo. A RAM ocorre quando microrganismos, como bactérias, se adaptam de maneiras que tornam os tratamentos atualmente disponíveis para infecções menos eficazes.

Foto: CDC, Unsplash

21,36 milhões

As pessoas que morreram em todo o mundo em 2021 tiveram sepse como causa imediata da morte ou em uma das etapas que levaram ao óbito.

4,71 milhões

As pessoas que morreram em 2021 sofriam de infecções resistentes a medicamentos, como infecções do trato respiratório inferior, da corrente sanguínea e intra-abdominais.

1,14 milhão

As mortes em 2021 foram causadas diretamente pela resistência antimicrobiana.

39 milhões

Prevê-se que o número de mortes por resistência antimicrobiana ocorra entre 2025 e 2050.

O Caso da Penicilina: PRSP

- 1 Uso intenso e repetido**
Décadas de prescrição indiscriminada de penicilina em larga escala.
- 2 Surgimento de cepas resistentes**
Emergência do *Streptococcus pneumoniae* resistente à penicilina (PRSP).
- 3 Perda de eficácia terapêutica**
Um antibiótico antes eficaz torna-se, em muitos casos, inútil frente à infecção.

PARTE 3

Emprego Racional dos Antibióticos

Indicações terapêuticas, profiláticas e os limites da prescrição consciente



é preciso avaliar se o paciente possui algum comprometimento sistêmico que indique o uso dos antibióticos mesmo havendo tal controle, sendo empregado como um complemento ao tratamento proposto

Casos em que o sistema imune do paciente não esteja controlando a infecção, a exemplo de abscesso com trismo ou celulite facial, que indicam a propagação infecciosa ou manifestações sistêmicas, como a presença de febre, se faz necessária a aplicação da terapêutica antibiótica.

A Autonomia do Cirurgião-Dentista



Na prática clínica odontológica, o cirurgião-dentista está apto a prescrever uma diversidade de medicamentos, resguardado por sua formação acadêmica e capacidade técnico-científica — o que exige responsabilidade profissional.

1

Prescrição individualizada

Cada caso deve ser avaliado isoladamente, respeitando dose e posologia.

2

Respaldo científico

A decisão deve ser criteriosa, consciente e baseada em evidências.

3

Responsabilidade compartilhada

O profissional também responde pelas consequências do uso indevido.

Uso Terapêutico vs. Uso Profilático

Uso Terapêutico

- Aplicado quando a infecção já está instalada.
- Indicado quando o sistema de defesa do paciente não controla o processo infeccioso.
- Deve ter atuação auxiliar — nunca substitui a remoção da causa.

Uso Profilático

- Administrado antes de sinais de infecção presentes.
- Objetivo: evitar infecção na região operada ou à distância.
- Indicado apenas para pacientes e procedimentos específicos.

Quando a Infecção Já Está Instalada



Trismo presente

Limitação de abertura bucal, sinal de disseminação do processo infeccioso.



Celulite facial

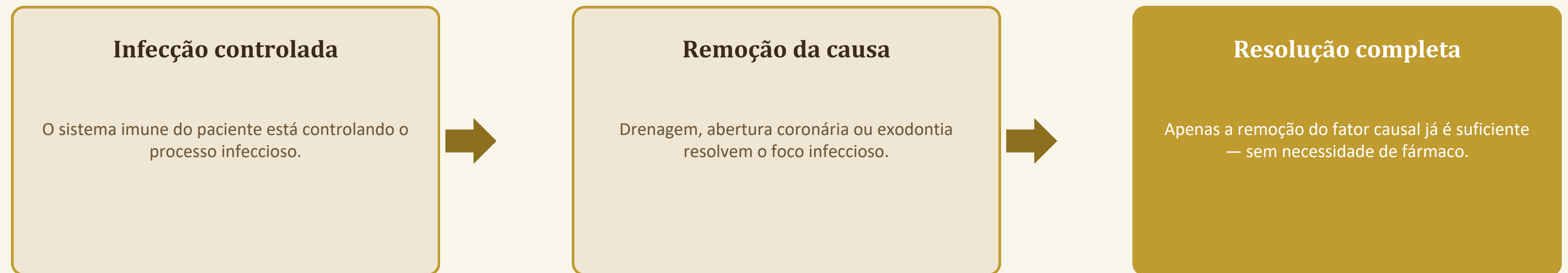
Edema difuso indicando propagação da infecção para tecidos moles.



Febre / manifestações sistêmicas

Sinais de que o organismo não está controlando a infecção sozinho.

Quando o Antibiótico NÃO é Necessário



Profilaxia Cirúrgica vs. Profilaxia à Distância

Profilaxia Cirúrgica

- Objetivo: prevenir infecção na própria região operada.
- Considera o risco de infecção do procedimento realizado.
- Recomendada em procedimentos de alta incidência infecciosa.

Profilaxia à Distância

- Objetivo: prevenir infecções em órgãos distantes (ex.: coração).
- Direcionada a pacientes suscetíveis (cardiopatas, imunossuprimidos).
- Baseada na bacteremia transitória gerada pelo procedimento.

De acordo com a literatura, não existem evidências científicas que justifiquem a profilaxia antibiótica em pacientes que são portadores de diabetes mas que estão com seus níveis controlados, e só deve ser realizado quando existirem sinais e sintomas sistêmicos de infecções ou quadro clínico da patologia estando em níveis descompensado (ZAFFALON et al 2022 apud LEMOS, 2014).

Há indicações para a profilaxia antibiótica baseada no tipo de procedimento a ser realizado. De acordo com a American Heart Association (AHA), a profilaxia antibiótica é recomendada para pacientes de alto risco, submetidos a procedimento dental que envolva tecido gengival ou região periapical do dente e para procedimentos que levam a perfuração da mucosa oral, como em exodontias; tratamento periodontal (inclusive sondagem, raspagem e alisamento radicular, cirurgias e sessões para manutenção); colocação ou inserção de implantes dentais e reimplantes de dentes avulsionados; instrumentação endodôntica ou cirurgia parendodôntica; colocação subgengival de tiras antibióticas; colocação inicial de bandas ortodônticas; injeções anestésicas locais intraligamentares; limpeza profilática de dentes ou implantes, quando previsto sangramento (ROCHA et al. 2008, apud Wilson et al, 2007, p.147).

Procedimentos com Indicação de Profilaxia



Exodontias

Perfuração da mucosa oral com exposição de tecido gengival.



Tratamento periodontal

Sondagem, raspagem, alisamento radicular e cirurgias.



Implantes e reimplantes

Colocação de implantes e reimplante de dentes avulsionados.



Cirurgia endodôntica

Instrumentação além do ápice ou cirurgia parendodôntica.



Tiras subgengivais

Colocação subgengival de fitas antibióticas locais.



Procedimentos com sangramento

Bandas ortodônticas, injeções intraligamentares e limpeza profilática.

Grupos que Exigem Atenção Especial



Cardiopatas

Sujeitos a endocardite bacteriana em procedimentos invasivos.



Imunocomprometidos

Sistema de defesa reduzido frente à bacteremia transitória.



Diabéticos descompensados

Prejuízo na migração de leucócitos e na cicatrização.



Próteses ortopédicas

Risco pontual, avaliado conforme condição sistêmica associada.



Pacientes renais / diálise

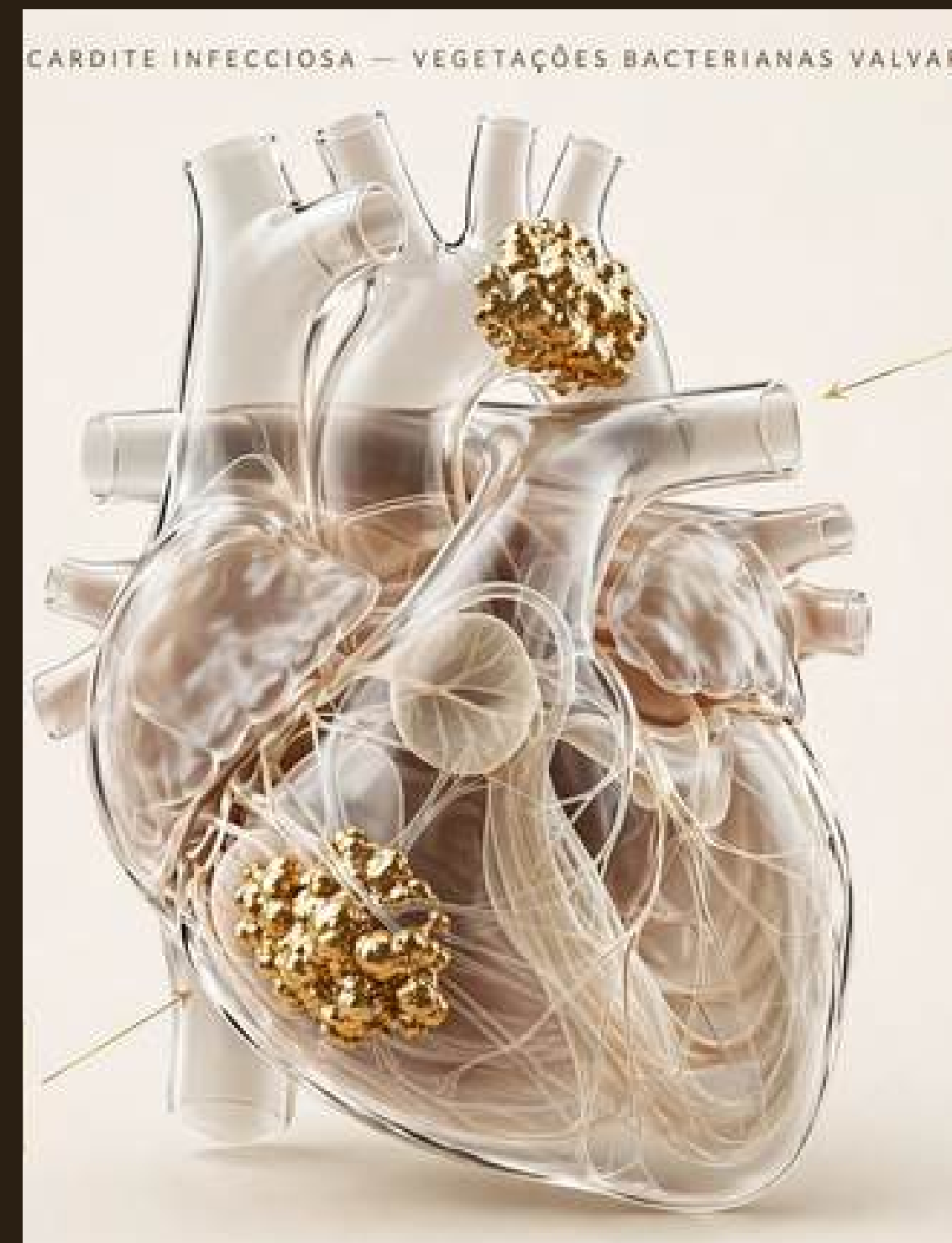
Uso ainda controverso na literatura científica.



PARTE 4

Endocardite Bacteriana

O principal fundamento histórico da profilaxia antibiótica em odontologia



O Que é a Endocardite Bacteriana?



Doença caracterizada pela inflamação e subsequente destruição de estruturas importantes do coração — o endocárdio, o endotélio e as valvas cardíacas — geralmente associada à colonização bacteriana dessas superfícies.

1

Streptococcus viridans

Principal microrganismo apontado como causador da doença.

2

Estruturas afetadas

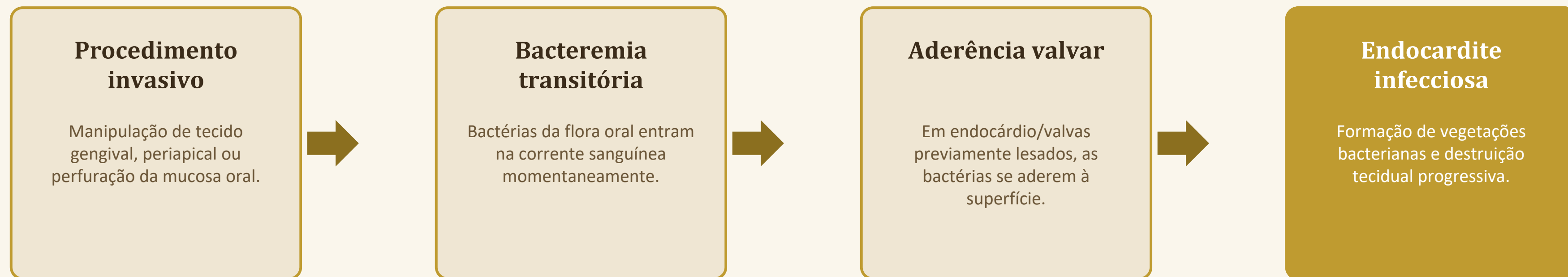
Endocárdio, endotélio vascular e valvas cardíacas.

3

Gravidade

Doença potencialmente grave, exigindo identificação precoce dos fatores de risco.

Do Procedimento Odontológico à Endocardite



DA BOCA AO CORAÇÃO

COMO A INFECÇÃO ODONTOLÓGICA PODE EVOLUIR
PARA ENDOCARDITE BACTERIANA



1

BIOFILME ORAL

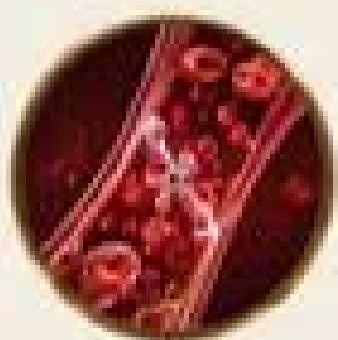
Acúmulo de bactérias no biofilme dental, principalmente em áreas de inflamação (gingivite, periodontite, cáries).



2

BACTEREMIA

Manipulações odontológicas ou infecções espontâneas permitem a entrada de bactérias na corrente sanguínea.



3

CORRENTE SANGÜÍNEA

As bactérias circulam pelo organismo e podem se alojar em válvulas cardíacas previamente alteradas.



4

COLONIZAÇÃO DA VALVA

Adesão das bactérias à válvula cardíaca, formando vegetações e iniciando o processo inflamatório.



5

ENDOCARDITE BACTERIANA

Infecção da válvula cardíaca com risco de complicações graves (embolias, insuficiência cardíaca, sepse).



Válvula cardíaca com vegetação bacteriana

GRUPOS DE ALTO RISCO PARA ENDOCARDITE BACTERIANA



PRÓTESES VALVARES
Mecânicas ou biológicas.



HISTÓRICO DE ENDOCARDITE
Aumenta o risco de recidiva.



CARDIOPATIAS CONGÊNITAS
Cianóticas ou com shunts residuais.



VALVOPATIAS ADQUIRIDAS
Estenose, regurgitação, doença reumática.



TRANSPLANTADOS CARDÍACOS
E outros com imunossupressão.

Em relação aos microrganismos responsáveis, o streptococcus viridans tem sido apontado como o principal causador da doença.

A saúde bucal é parte da saúde do coração.
PREVENÇÃO É O MELHOR TRATAMENTO.

PONTOS-CHAVE PARA O CLÍNICO

- ✓ Avaliar o risco cardíaco do paciente.
- ✓ Promover higiene bucal adequada.
- ✓ Indicar profilaxia apenas para grupos de alto risco.
- ✓ Evitar procedimentos eletivos em infecções ativas.
- ✓ Trabalhar em conjunto com o cardiologista.

A Bacteremia é Transitória

Minutos

a 1 hora: tempo em que as bactérias são normalmente eliminadas da corrente sanguínea pelo sistema de defesa do hospedeiro

Persiste

em pacientes clinicamente comprometidos, aumentando o risco de disseminação e colonização cardíaca

Fonte: Buonavoglia et al. (2021), apud Lockhart (2008).

Bacteremia: Hábitos Diários vs. Procedimento Odontológico

Hábitos Rotineiros

- Escovação dentária, uso de fio dental e mastigação também geram bacteremia transitória.
- Ocorrem com frequência muito maior ao longo da vida do paciente.
- Podem estar mais associados ao surgimento da doença do que procedimentos pontuais.

Procedimento Odontológico Invasivo

- Gera bacteremia de magnitude potencialmente maior em um único evento.
- Representa, segundo a literatura, um risco mínimo e pontual.
- Fundamenta a indicação restrita da profilaxia a grupos específicos.

Pacientes Descritos pela AHA



Válvula protética

Usuários de válvula protética, incluindo transcater.



Ajuste cirúrgico valvar

Pacientes submetidos a ajuste de transcater ou válvula protética.



Dispositivos de suporte

Uso de dispositivos de assistência ventricular ou coração implantável.



Endocardite prévia

Histórico pessoal de episódio anterior de endocardite bacteriana.



Cardiopatía congênita

Malformação cardíaca estrutural presente desde o nascimento.



Transplante cardíaco

Pacientes transplantados, com sistema imunológico fragilizado.

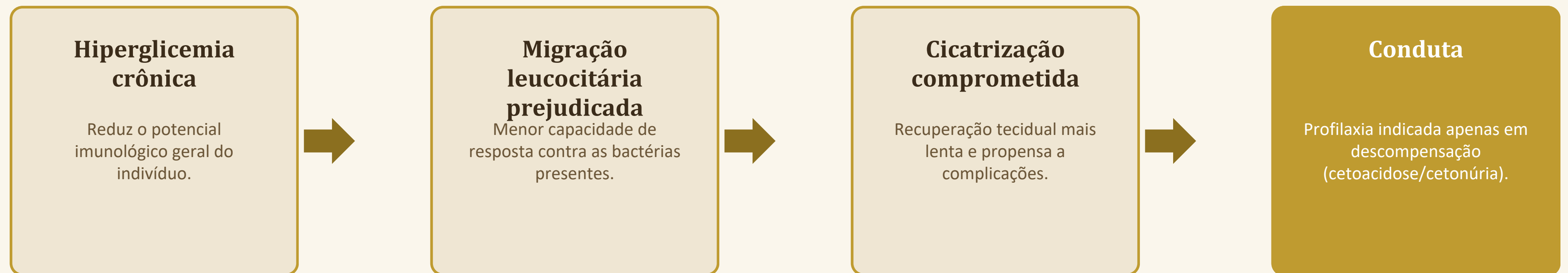
PARTE 5

Populações Específicas

Diabetes, imunossupressão, próteses ortopédicas e doença renal



Diabetes Descompensada e Risco Infeccioso



PROFILAXIA ANTIBIÓTICA

QUANDO E PARA QUEM É INDICADA?

A profilaxia antibiótica é o uso de antibióticos de forma preventiva, antes que haja sinais de infecção, com o objetivo de evitar infecções pós-operatórias.



1 PACIENTES DE ALTO RISCO QUE DEVEM SER IDENTIFICADOS

Estes pacientes, ao serem submetidos aos procedimentos descritos, estão à mercê do processo infeccioso à distância pós-tratamento odontológico.



Cardiopatas
(risco de endocardite bacteriana)



Imunocomprometidos



Diabéticos
descompensados



Portadores de
próteses ortopédicas



Pacientes
renais



Para estes pacientes, o emprego preventivo dos antibióticos é justificado pela literatura.

QUEM SÃO OS PACIENTES COM RISCO DE ENDOCARDITE BACTERIANA?

Segundo a AHA, incluem-se:



Usuários de
válvula protética
transcater



Portadores de
válvulas protéticas



Ajuze de válvula
protética (cirúrgico
ou transcater)



Dispositivos de
assistência ventricular
ou coração implantados



Histórico de
endocardite bacteriana



Cardiopatia congênita
ou transplante
de coração

“

O uso profilático de antibióticos em odontologia pode ser instituído com o objetivo de prevenir infecções na própria região operada (profilaxia cirúrgica) ou na prevenção de infecções à distância, em pacientes suscetíveis.

Andrade et al. (2014)

2

ENDOCARDITE BACTERIANA UMA INFECÇÃO GRAVE

É uma doença onde há inflamação e subsequente destruição de estruturas importantes do coração (endocárdio, endotélio e válvulas cardíacas).

Os procedimentos odontológicos podem levar a uma bacteremia transitória, e as bactérias presentes podem se disseminar para o coração, provocando o quadro de endocardite.

(DUARTE et al. 2017 apud Barros et al. 2011).



O *Streptococcus viridans* tem sido apontado como o principal causador da doença.

A bacteremia ocorre logo após o procedimento e diminui com o tempo. Em geral, as bactérias são eliminadas da corrente sanguínea de alguns minutos a 1 hora após o procedimento, sem riscos potenciais, mas podem persistir em pacientes clinicamente comprometidos.

(BUONAROLI et al. 2021 apud Luciani, 2008, p.3)



OUTROS FATORES IMPORTANTES

Tem sido discutido o emprego da profilaxia antibiótica como prevenção à endocardite bacteriana, associando sua ocorrência a hábitos rotineiros, como a escovação dentária, que causaria a bacteremia transitória, sendo este fator mais associado ao surgimento da doença do que ao tratamento odontológico invasivo, que teria um risco mínimo.

INDICAÇÕES GERAIS BASEADAS NO TIPO DE PROCEDIMENTO

Segundo a American Heart Association (AHA), a profilaxia antibiótica é recomendada para:



Procedimentos que envolvam tecido gengival ou região periapical do dente.



Procedimentos que levam à perfuração da mucosa oral (ex.: exodontias).



Tratamento periodontal (inclusive sondagem, raspagem e alisamento radicular, cirurgias e manutenção).



Colocação ou inserção de implantes dentais e reimplantes de dentes avulsados.



Instrumentação endodôntica ou cirurgia periradicular.



Colocação subgengival de tiras antibióticas.



Colocação inicial de bandas ortodônticas.



Injeções anestésicas locais intraalveolares.



Limpeza profilática de dentes ou implantes, quando previsto sangramento.

(BOCHÁ et al. 2008, apud Wilson et al. 2007, p.147)

*Prevenir
também é
cuidar.*

QUANDO A PROFILAXIA É INDICADA?

Alguns pacientes apresentam maior risco de infecções e podem se beneficiar da profilaxia antibiótica em procedimentos odontológicos.



PACIENTES DIABÉTICOS DESCONTROLADOS

Reduzem o potencial imunológico, prejudicam a migração dos leucócitos, a capacidade de combater bactérias e a cicatrização.



COMO IDENTIFICAR O DESCOMPENSADO?

- Presença de cetoacidose do sangue
- Presença de cetonúria



Se descompensado: procedimento apenas em situação de urgência. Caso contrário, restabelecer o controle glicêmico.



Não há evidências científicas que justifiquem a profilaxia em pacientes com diabetes controlado. Só deve ser realizada se houver sinais e sintomas sistêmicos de infecção ou quadro clínico descompensado.

(ZAFFALON et al., 2022 apud LÊMONS, 2014).



PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS EM CASOS ESPECÍFICOS

Precisam de antibioticoterapia em situações específicas, como:



Baixa contagem de leucócitos granulócitos.



Quimioterapia.



Transplantados de medula óssea.



Não há indicação para pacientes com HIV em procedimentos de exodontia, cirurgia periodontal e restaurações (risco similar ao de um paciente saudável).



Não há evidências para pacientes com leucemia, mas podem apresentar alterações na flora bucal.

(ANDRADE et al., 2014).



PRÓTESE ORTOPÉDICA

NÃO É INDICADA ROTINEIRAMENTE

Pacientes que fazem uso de prótese ortopédica, placas, parafusos, pinos ou próteses articulares totais não necessitam de profilaxia, a menos que apresentem condições de risco:

- ✓ Imunocomprometimento (artrite reumatoide, lúpus, etc.)
- ✓ Diabetes tipo I (insulino-dependente)
- ✓ Subnutrição
- ✓ Hemofilia
- ✓ Primeiros 2 anos após a colocação da prótese
- ✓ Histórico prévio de infecções de próteses articulares



Se houver complicações ou necessidade de substituição da prótese, a decisão deve ser feita em conjunto com o cirurgião ortopédico.

(ANDRADE et al., 2014; MATOS et al., 2014).



PACIENTES RENAIIS EM DIÁLISE

O uso da profilaxia é controverso. Não há incidência de endocardite infecciosa relacionada a tratamentos dentários, pois as infecções ocorrem por microrganismos da pele que entram pela fistula arteriovenosa.



Não há conduta definida para pacientes renais crônicos. A AHA recomenda a profilaxia apenas para aqueles com risco cardíaco e que fazem hemodíalise.

(SANTANA, 2022 apud Surgil, Howell, Perry & Kotliar, 2016).



QUANDO NECESSÁRIO:

Escolher cuidadosamente os fármacos, priorizando os de melhor perfil de segurança para o paciente.

Cuidado individualizado também é prevenção.

Quimioterapia/Transplante vs. HIV

Quimioterapia e Transplante de Medula

- Baixa contagem de leucócitos granulócitos aumenta o risco infeccioso.
- AHA recomenda profilaxia em tratamentos odontológicos invasivos.
- Objetivo: prevenir infecção generalizada por *Streptococcus viridans*.

Pacientes com HIV

- Sem indicação de profilaxia para exodontia, cirurgia periodontal ou restaurações.
- Risco de infecção comparável ao de um paciente saudável.
- Uso desnecessário pode favorecer infecções fúngicas resistentes.

Regra Geral vs. Situações de Exceção

Regra Geral

- Não é indicada profilaxia antimicrobiana inicial para pacientes com placas, parafusos ou próteses articulares.
- O risco de disseminação hematogênica após procedimento odontológico é considerado baixo.

Exceções que Justificam Profilaxia

- Imunocomprometimento (artropatias, artrite reumatoide, lúpus).
- Diabetes tipo I insulino-dependente e subnutrição.
- Hemofilia e primeiros dois anos após colocação da prótese.
- História prévia de infecção de prótese articular.

1 PROFILAXIA ANTIBIÓTICA EM PACIENTES DE RISCO

QUEM PRECISA • QUANDO INDICAR • O QUE EVITAR



QUIMIOTERAPIA E TRANSPLANTADOS DE MEDULA ÓSSEA

PROFILAXIA INDICADA

Conforme recomendado pela AHA, pacientes que realizam a quimioterapia, assim como os transplantados de medula óssea devem receber a profilaxia nos tratamentos odontológicos invasivos como prevenção a possível infecção generalizada decorrente do estreptococos viridans.



Streptococcus viridans

Principal agente associado à endocardite infecciosa.



PACIENTES COM HIV

SEM INDICAÇÃO DE PROFILAXIA

Os pacientes com HIV não têm essa indicação para procedimentos de exodontia, cirurgia periodontal e restaurações, uma vez que o risco de infecções, comparado a um paciente saudável, são equivalentes.



Exodontia



Cirurgia periodontal



Restaurações



ALÉM DISSO...



A sua utilização poderia provocar um aumento de fungos resistentes ao medicamento



E ocasionar uma grande infecção



AHA
AMERICAN
HEART
ASSOCIATION

"A prevenção da endocardite infecciosa em pacientes com maior risco deve ser individualizada e baseada em evidências, seguindo as recomendações da AHA."

AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA)



A DECISÃO É CLÍNICA. O OBJETIVO É A SEGURANÇA.

AVALIE O RISCO, SIGA AS DIRETRIZES, PROTEJA SEUS PACIENTES.

Doença Renal Crônica e Hemodiálise

1

Uso controverso

Não há evidência de endocardite relacionada a tratamentos dentários nesses pacientes.

2

Origem real das infecções

Geralmente por microrganismos da pele que adentram via fístula arteriovenosa.

3

Recomendação da AHA

Profilaxia apenas para pacientes com risco cardíaco associado que fazem hemodiálise.

4

Escolha do fármaco

Priorizar antibióticos de metabolização hepática, poupando a função renal comprometida.

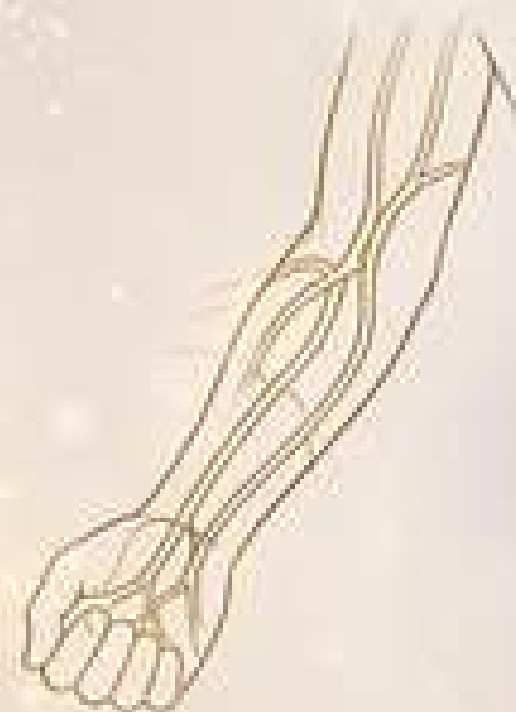
5 PACIENTES RENAIS, DIÁLISE E PROFILAXIA ANTIBIÓTICA

DIVISÃO 1



Doença renal crônica

DIVISÃO 2



Pacientes em diálise -
fístula arteriovenosa

DIVISÃO 3

A literatura relata ser controverso o uso da profilaxia antibiótica, pois não há incidência de endocardite infecciosa com causa relacionada a tratamentos dentários com chance de bacteremia transitória nestes pacientes.

DIVISÃO 4



Infecções ocorrem por microrganismos da pele que adentram pelo acesso vascular da fístula, não por via oral

DIVISÃO 5

aconselha o emprego da profilaxia antibiótica somente em pacientes que apresentam risco cardíaco e fazem hemodiálise



Conclusão executiva

Profilaxia não indicada rotineiramente - avaliar risco individual - literatura controversa

“

Não há ainda evidências científicas que assegurem a necessidade do emprego da profilaxia antibiótica em pacientes portadores de leucemia.

Andrade et al. (2014) — ausência de consenso na literatura

2

Pacientes portadores de leucemia e profilaxia antibiótica

Com relação aos pacientes portadores de leucemia, não há ainda evidências científicas que assegurem a necessidade do emprego da profilaxia antibiótica nos procedimentos sujeitos a bacteremia transitória. Contudo, esses indivíduos podem apresentar uma modificação na flora bucal com a predominância de Enterobacteriaceae e a *Klebsiella pneumoniae*, o que fundamentaria o uso dos antibióticos, mas são apenas teorias (ANDRADE et al, 2014).



Sem evidência definitiva para profilaxia

Até o momento, estudos clínicos não demonstram benefício consistente da profilaxia antibiótica antes de procedimentos que causam bacteremia transitória em pacientes leucêmicos.

- Ausência de consenso em diretrizes atuais
- Risco de resistência antimicrobiana
- Necessidade de avaliação caso a caso

Microorganismos em destaque



Klebsiella pneumoniae (dourado) - Enterobacteriaceae (lavanda)



Modificação da flora bucal

— predominância de enterobactérias —

- Alteração do microbioma oral em imunossuprimidos
- Aumento relativo de Gram-negativas entéricas
- Teoria em estudo: impacto clínico incerto

Hipótese baseada em alterações observadas em cultura oral

3

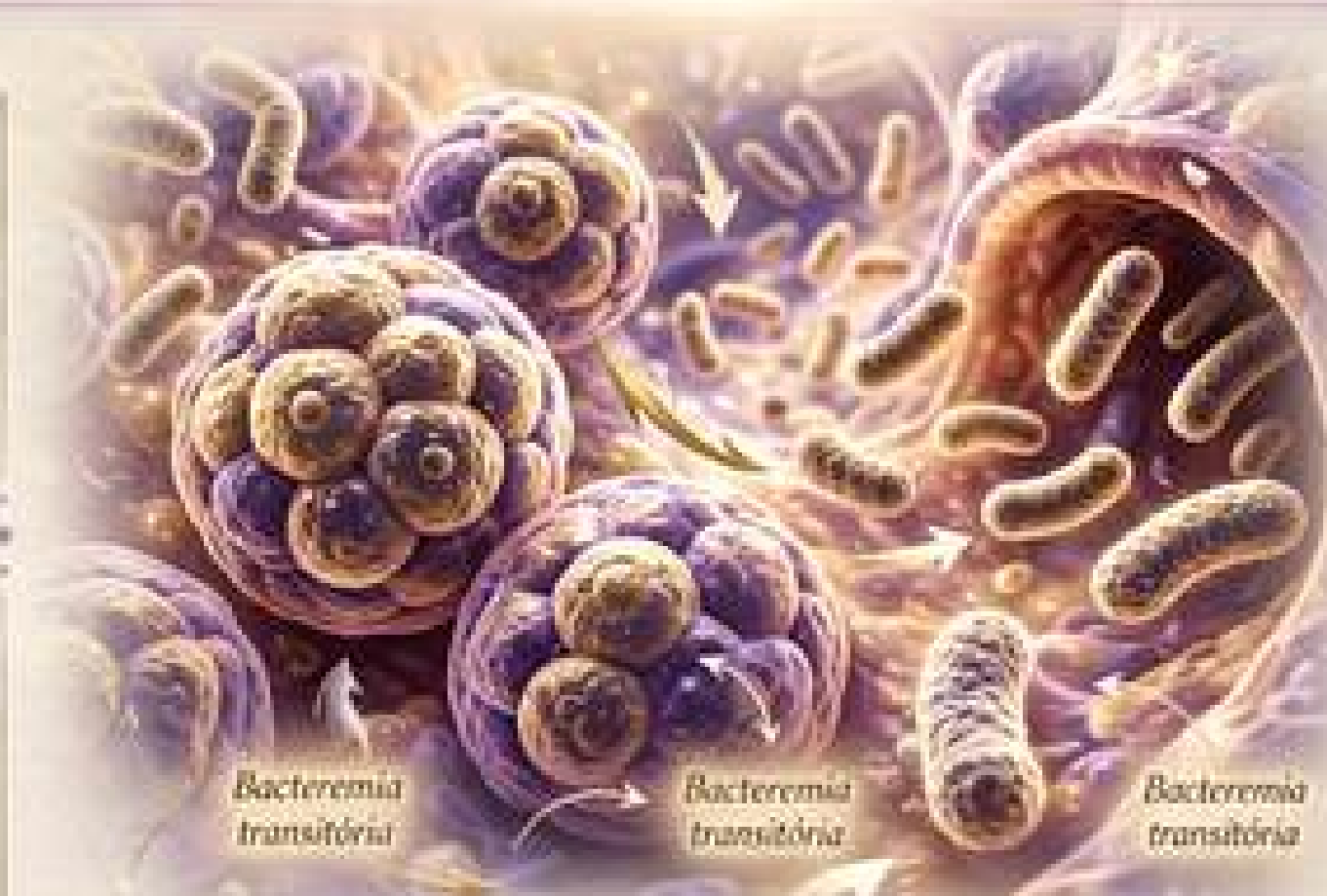
PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS E PROFILAXIA ANTIBIÓTICA

Os pacientes imunossuprimidos também necessitam da antibioticoterapia, mas apenas em determinados casos, como descreve a literatura. Nesse sentido, segundo Andrade et al (2014), "indivíduos com baixa contagem de leucócitos granulócitos podem apresentar um risco maior de infecções induzidas por procedimentos que causam bacteremia transitória". Dessa forma, tais pacientes precisam ser submetidos a profilaxia.



Baixa contagem de granulócitos
= maior vulnerabilidade

- Queda de neutrófilos reduz defesa inata
- Resposta imune comprometida
- Suscetibilidade aumentada a patógenos



Risco aumentado durante procedimentos que causam bacteremia transitória



Quando indicar profilaxia:

- ☒ Imunossupressão severa
- ☒ Procedimentos invasivos
- ☒ Risco de bacteremia
- ☒ Avaliação caso a caso



REFERÊNCIA: ANDRADE ET AL., 2014 — PROFILAXIA ANTIBIÓTICA EM PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS • LITERATURA CIENTÍFICA

EVIDÊNCIA
CLÍNICA
• 2014

4 PACIENTES COM PRÓTESE ORTOPÉDICA E PROFILAXIA ANTIMICROBIANA

Em pacientes que fazem uso de prótese ortopédica e utilizam placas, parafusos, pinos ou próteses articulares totais não é indicada a profilaxia antimicrobiana inicialmente como forma de prevenção à disseminação infecciosa que possa vir a ocorrer por via sanguínea após o procedimento odontológico, a menos que apresente determinadas condições de risco.

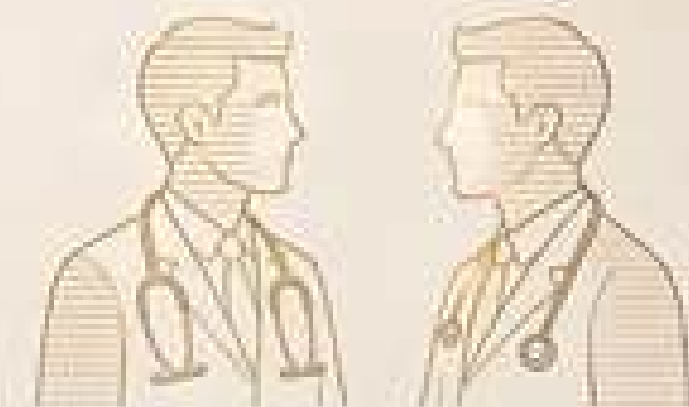
PRÓTESE ARTICULAR TOTAL DE JOELHO



✓ Quando INDICAR profilaxia:

- ✓ Imunocomprometimento devido a artropatias inflamatórias, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, irradiação ou uso de imunossupressores;
- ✓ Diabetes tipo I (insulino-dependente);
- ✓ Subnutrição;
- ✓ Hemofilia;
- ✓ Primeiros dois anos após colocação de prótese total articular;
- ✓ História prévia de infecções de próteses articulares (ANDRADE *et al*, 2014, p.75)

Decisão compartilhada



Se o paciente precisar substituir a prótese e apresentar complicações, pode ser necessário o uso de antimicrobiano para procedimento odontológico invasivo, decisão tomada pelo cirurgião-dentista após consulta com cirurgião ortopédico para avaliar o quadro clínico (MATOS *et al*, 2024).



PARTE 6

Protocolos de Prescrição

O padrão-ouro da profilaxia e as alternativas para pacientes alérgicos



O protocolo da antibioticoprofilaxia como prevenção a infecções à distância é bem consolidado na literatura, que segundo a American Heart Association, é a utilização da

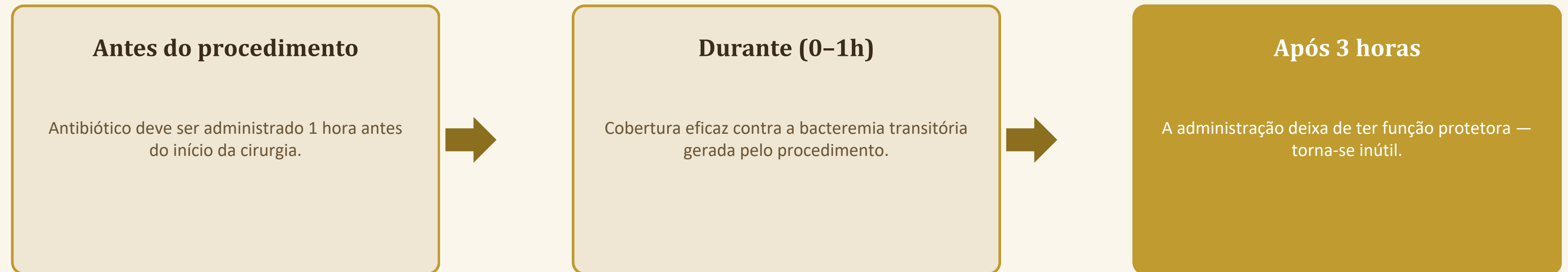
- amoxicilina 2 gramas em adultos, sendo empregada como
- opção aos pacientes sensíveis às penicilinas a cefalexina 2 gramas ou a azitromicina 500mg, ambas administradas 1 hora antes do procedimento

Antibioticoprofilaxia: Protocolo Consolidado

Situação do Paciente	Fármaco	Dose	Momento
Padrão (sem alergia)	Amoxicilina	2 g (VO)	1 hora antes do procedimento
Alérgico à penicilina (1)	Cefalexina	2 g (VO)	1 hora antes do procedimento
Alérgico à penicilina (2)	Azitromicina	500 mg (VO)	1 hora antes do procedimento

Fonte: Wilson et al. (2021) apud American Heart Association — dose única pré-operatória.

A Janela de Eficácia da Profilaxia



Segundo Burke (1961), apud Almeida (2020): a antibioticoterapia iniciada 1 hora antes do procedimento é eficaz; passadas 3 horas, perde a função desejada.

Princípios para o Emprego Correto

1

Avaliação do risco

Examinar o risco de infecção específico daquele procedimento cirúrgico.

2

Escolha correta do antimicrobiano

Selecionar o fármaco adequado ao espectro de ação necessário.

3

Dose e momento ideais

Prescrever na dose adequada, administrada no momento correto (pré-operatório).

4

Racionalização do uso

Considerar sempre a real necessidade antes de qualquer prescrição.

PARTE 7

Extrações e Terceiros Molares

Onde estão as maiores controvérsias sobre o uso profilático



PROFILAXIA CIRÚRGICA.

Nos Estados Unidos, a profilaxia antibiótica cirúrgica é recomendada somente em procedimentos associados a uma alta incidência de infecção e/ ou na implantação de peças protéticas ou corpos estranhos volumosos. Com base nesses critérios, já foi sugerido que, em pacientes imunocompetentes, a cirurgia de instalação de implantes dentários talvez seja a única intervenção odontológica na qual poderia estar indicado o uso profilático de antibióticos, embora existam opiniões contrárias a tal conduta (ANDRADE et al, 2014, p.73).

A Favor vs. Contra a Profilaxia em Extrações

Argumentos a Favor

- Restrita, na prática, às exodontias de terceiros molares.
- Casos de maior trauma cirúrgico e tempo operatório prolongado.
- Indicada quando há alto risco de infecção pós-operatória.

Argumentos Contra

- Prevalência de infecção pós-operatória de apenas ~10% — risco considerado mínimo.
- Poucas evidências convincentes apoiam o uso rotineiro em pacientes saudáveis.
- Biossegurança adequada já reduz consideravelmente o risco infeccioso.

ANTIBIOTICOPROFILAXIA EM EXTRAÇÕES - FOCO EM TERCEIROS MOLARES

Para as extrações, o emprego da antibioticoprofilaxia, de acordo com estudos contínuos, tem se limitado exclusivamente para as exodontias de terceiros molares, apesar de ainda ser um tópico muito discutido e controverso, pois alguns autores não concordam com esse uso nas extrações. Tal pensamento é baseado no risco de ocorrência de infecção pós-operatória, o que restringe seu uso para as situações com elevadas chances de acontecimento.

01



Exodontia de terceiros molares

02



RISCO

BENEFÍCIO

Tópico controverso -
autores divergentes

03

“

“O uso da antibioticoprofilaxia permanece limitado apenas às exodontias de terceiros molares, conforme revisão de estudos atuais.”

— Consenso: uso seletivo e justificado

04



Risco de infecção pós-operatória
elevado = indicação restrita

05

- ✓ Uso restrito a alto risco
- ✓ Avaliar caso a caso
- ✓ Evitar uso rotineiro
- ✓ Basear em evidências

Amoxicilina Isolada vs. Amoxicilina + Clavulanato

Amoxicilina Isolada

- Uso preventivo não proporciona redução significativa no risco de alveolite.
- Não há justificativa científica para prescrição rotineira apenas com esse fármaco.

Amoxicilina + Ácido Clavulânico

- Quando combinada, o risco de alveolite é significativamente reduzido.
- Mesmo assim, a baixa prevalência de infecções não justifica o uso rotineiro.

Fatores a Considerar Antes da Extração



Profundidade de impactação

Grau de dificuldade de acesso ao elemento dentário incluso.



Necessidade de osteotomia

Remoção óssea aumenta o trauma cirúrgico associado.



Tempo cirúrgico estendido

Procedimentos prolongados elevam o risco infeccioso.



Inflamação local

Grau de inflamação prévia na região a ser tratada.

FLUXOGRAMA DE DECISÃO CLÍNICA - PRESCRIÇÃO ANTIBIÓTICA EM ODONTOLOGIA

VOGUE HEALTH — EDITION CLÍNICA • PROTOCOLO CLÍNICO DE PRESCRIÇÃO ANTIBIÓTICA • BASEADO EM DIRETRIZES ADA | SBRO | 2024



DIRETRIZES FINAIS & MONITORAMENTO



INDICAÇÃO CLÍNICA

- Infecção bacteriana confirmada ou suspeita sistêmica
- Risco de disseminação / celulite / febre



FATORES DE RISCO

- Diabetes, imunossupressão, cardiopatia, prótese valvular
- Idade avançada, quimioterapia, corticosteroides



REAVALIAÇÃO & SEGURANÇA

- Reavaliar em 48-72h • Suspende se sem melhora
- Registrar reação adversa e ajustar conforme cultura

Legenda: SIM • NÃO • Fluxo baseado em diretrizes científicas atuais — Uso racional de antibióticos em odontologia | 2024

PARTE 8

Uso Irracional e Resistência

As consequências globais da prescrição sem critério científico



O Papel do Cirurgião-Dentista na Prescrição

~10%

de todos os antibióticos prescritos na área da saúde, no mundo, são de responsabilidade de cirurgiões-dentistas

+49%

foi o aumento nas prescrições odontológicas de antibióticos durante a pandemia de COVID-19

+28%

acima do patamar anterior, mesmo após o fim do período mais crítico da pandemia

Fonte: Cordova (2023); Contaldo (2023) apud Duncan (2021).

O Peso da Resistência Bacteriana

1,27 mi

de óbitos no mundo diretamente atribuídos à resistência aos antibióticos durante a pandemia

4,95 mi

de mortes adicionais associadas indiretamente à resistência antimicrobiana no mesmo período

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023).

Fatores que Alimentam o Uso Irracional



Conhecimento desatualizado

Formação limitada ou não atualizada do profissional prescritor.



Prescrição por medo

Receio de complicações pós-operatórias, sem respaldo científico real.



Automedicação da população

Prática sociocultural que dificulta o controle do uso indevido.



Falhas na fiscalização

Venda de antimicrobianos sem prescrição em algumas drogarias.

PARTE 9

Medidas de Controle

As respostas regulatórias nacionais e internacionais ao problema



Medidas de Controle: Brasil vs. Mundo

ANVISA (Brasil)

- RDC nº 44/2010: receita em duas vias, retendo uma na farmácia (validade de 10 dias).
- Objetivo: dificultar o uso de antimicrobianos sem prescrição.
- Ainda há lacunas de fiscalização em drogarias no país.

OMS (Mundial)

- Plano de ação global sobre resistência antimicrobiana (Assembleia Mundial da Saúde, 2015).
- Semana de Conscientização sobre Antibióticos (18 a 24 de novembro).
- Estímulo a programas de gerenciamento e educação de profissionais de saúde.



Prescrever com Ciência, Não com Medo

Síntese dos principais aprendizados para a prática clínica odontológica

- ✓ O antibiótico é sempre coadjuvante — a remoção da causa infecciosa é prioritária.
- ✓ A profilaxia deve ser restrita aos grupos de risco cientificamente comprovados.
- ✓ O protocolo padrão-ouro é a amoxicilina 2g, 1 hora antes do procedimento.
- ✓ O uso irracional compromete vidas ao alimentar a resistência bacteriana global.
- ✓ A responsabilidade pela mudança de conduta começa na formação do cirurgião-dentista.

Principais Referências do Artigo

- ANDRADE, E. et al. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014.
- ANVISA. RDC nº 44, de 26 de outubro de 2010.
- BAUER, H.C. Associação entre o tempo cirúrgico e infecção pós-operatória na exodontia de terceiros molares. USP, 2016.
- BUONAVOGLIA, A. et al. Antibiotics or no antibiotics. Antibiotics, v.10, n.5, 2021.
- CONTALDO, M. et al. Antibiotics in Dentistry: A Narrative Review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2023.
- CORDOVA, P. et al. Engaging the Global Dental Profession to Help Tackle Antibiotic Resistance. Medical Sciences Forum, 2023.
- DUARTE, A. et al. Quando realizar a profilaxia antibiótica em pacientes com alto risco para endocardite infecciosa? UNIUBE, 2017.
- OBEROI, S. et al. Antibiotics in dental practice: how justified are we. International Dental Journal, 2015.

- ROCHA, L. et al. Conhecimentos e condutas para a prevenção da endocardite infecciosa. Robrac, 2008.
- SANTOS, A. A relevância do uso racional dos antibióticos na odontologia. UNILAB, 2018.
- SILVEIRA, G. et al. Estratégias utilizadas no combate à resistência bacteriana. Química Nova, 2006.
- SOUZA, L.A.B.; COSTA JUNIOR, F.; PINTO, E.V. O uso racional dos antibióticos na odontologia. REASE, v.10, n.11, 2024.
- WILSON, W. et al. Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis. Circulation, 2021.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. Resistência antimicrobiana. 2023.
- ZAFALON, G. et al. Profilaxia antibiótica em pacientes portadores de diabetes mellitus insulino-dependentes. USJT, 2022.

Questões

Questões Artigo Endocardite Bacteriana:

- 1- Explique como procedimentos odontológicos invasivos podem atuar como fator desencadeante para a Endocardite Infeciosa (EI) e discorra sobre a importância da anamnese dirigida na identificação de pacientes que pertencem aos grupos de risco, conforme discutido no artigo.
- 2- As diretrizes da American Heart Association (AHA) e de outras entidades de saúde passaram por mudanças significativas nas últimas décadas, restringindo o uso da antibioticoprofilaxia. Com base no artigo, apresente pelo menos dois argumentos que justifiquem essa restrição e a tendência atual de não indicar antibióticos para todos os pacientes com sopro cardíaco ou prolapso de válvula mitral.
- 3- Um paciente de alto risco para endocardite bacteriana necessita realizar uma exodontia, porém relata ser alérgico à penicilina. Com base nos protocolos atuais apresentados no texto, qual deve ser a conduta farmacológica do cirurgião-dentista? Especifique o fármaco, a via de administração, a dosagem e o tempo de antecedência ao procedimento.